SHOCK Y REANIMACIÓN EN TRAUMA

DR. MARTIN VASQUEZ

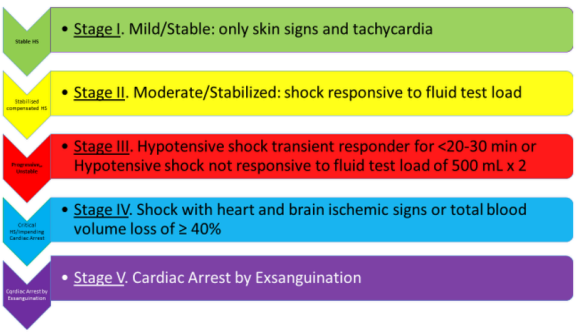
TIPOS DE SHOCK EN TRAUMA

- Hipovolémico/hemorrágico: el más frecuente en trauma; por pérdida del volumen circulante.
- Cardiogénico: por falla de bomba (ej. contusión miocárdica, taponamiento).
- Obstructivo: neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar masiva.
- Distributivo: shock neurogénico (lesión medular) o séptico.

Distributivo	Obstructivo	Hipovolémico	Cardiogénico	
• Corazón hipercontráctil (inicialmente) • Corazón hipocontráctil (tardío)	• Derrame pericárdico • Sobrecarga del ventrículo derecho • Corazón hipercontráctil	• Corazón hipercontráctil • Corazón de pequeño tamaño	• Corazón hipocontráctil • Corazón dilatado	Bomba
• Vena cava inferior normal o colapsada • Vena yugular interna normal o colapsada • Derrame pleural (empiema) • Ascitis (peritonitis)	• Vena cava inferior dilatada • Vena yugular interna dilatada • Ausencia de deslizamiento pleural (neumotórax)	• Vena cava inferior colapsada • Vena yugular interna colapsada • Ascitis • Derrame pleural	• Vena cava inferior dilatada • Vena yugular interna dilatada • Síndrome intersticial pulmonar • Ascitis • Derrame pleural	Tanque
• Sin alteraciones	• Trombosis venosa profunda en miembros inferiores	• Aneurisma de aorta abdominal • Disección de aorta	• Sin alteraciones	Tubería

CLASES DE SHOCK HEMORRÁGICO (ATLS)

- Clase I: pérdida <15% de la volemia; signos vitales normales.
- Clase II: 15-30%; taquicardia, taquipnea, presión de pulso disminuida.
- Clase III: 30-40%; hipotensión franca y confusión.
- Clase IV: >40%; hipotensión severa, letargo, riesgo vital inminente.



MONITOREO DE LA REANIMACIÓN

- Lactato sérico y su aclaramiento son buenos marcadores de perfusión tisular y respuesta al tratamiento.
- La meta es normalizar el lactato y los signos de perfusión, no solo la presión arterial.

REANIMACIÓN CON LÍQUIDOS

- Acceso vascular: dos vías periféricas de grueso calibre como primera opción.
- Cristaloides: bolo inicial mientras se consiguen hemoderivados; evitar la reanimación excesiva con cristaloides.
- Hipotensión permisiva: mantener presión sistólica baja (80-90 mmHg) hasta controlar el sangrado, salvo en trauma craneoencefálico.

TRANSFUSIÓN MASIVA Y CONTROL DE DAÑOS

- Protocolo de transfusión masiva: relación 1:1:1 de glóbulos rojos, plasma y plaquetas.
- Ácido tranexámico: en las primeras 3 horas del trauma, reduce la mortalidad por sangrado.
- Cirugía de control de daños: priorizar controlar el sangrado y la contaminación sobre la reparación definitiva en el paciente inestable.

VASOPRESORES EN SHOCK HEMORRÁGICO

- Se usan solo como puente mientras se controla el sangrado y se repone el volumen, nunca como sustituto de la reanimación con líquidos y hemoderivados.